

Examen físico ORL básico: otoscopía, rinoscopía, orofaringe y laringe indirecta

1. Introducción y relevancia clínica

El **examen físico otorrinolaringológico (ORL)** es una herramienta fundamental para el diagnóstico clínico en medicina general y en atención primaria.

Permite identificar las causas más frecuentes de **otalgia, hipoacusia, rinorrea, epistaxis, disfagia y disfonía**, que constituyen una parte importante de las consultas médicas ambulatorias.

La correcta ejecución del examen ORL evita diagnósticos erróneos, tratamientos innecesarios y derivaciones tardías.

Además, muchos signos clínicos de patologías graves —como tumores laríngeos, abscesos faríngeos o perforaciones timpánicas— pueden detectarse con una exploración bien realizada.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema evalúa las **competencias prácticas y semiológicas** del médico general: cómo examinar, qué observar y cómo interpretar hallazgos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El examen ORL se basa en la **exploración sistemática** de los cinco componentes anatómicos:

1. **Oído**
2. **Nariz y senos paranasales**
3. **Orofaringe**
4. **Laringe**
5. **Cuello (linfático y glandular)**

Cada uno requiere comprensión anatómica, técnica adecuada y observación dirigida hacia los signos clínicos más relevantes.

Los objetivos del examen son:

- Identificar alteraciones estructurales o inflamatorias.
 - Correlacionar síntomas (dolor, secreción, obstrucción) con signos objetivos.
 - Establecer indicaciones de tratamiento o derivación.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

A continuación se detalla el **procedimiento del examen físico ORL** y los **principales hallazgos clínicos**, junto con su correlación diagnóstica.

3.1 Exploración del oído

A) Inspección externa

- Observar pabellón auricular, piel y conducto externo.
- Buscar signos de inflamación, eritema, supuración o deformidad.
- Palpar trago y mastoides (dolor: sugiere otitis externa o mastoiditis).

B) Otoscopía

Instrumento: otoscopio con espéculo del tamaño adecuado (adulto: 5 mm; niño: 3 mm).

Técnica:

- Tirar pabellón hacia **arriba y atrás** (adultos) o **abajo y atrás** (niños).
- Introducir suavemente el espéculo siguiendo el eje del conducto.
- Observar conducto y membrana timpánica.

Hallazgos normales:

- **Conducto auditivo:** piel intacta, leve cerumen.
- **Membrana timpánica:** color gris perlado, traslúcida, con reflejo luminoso anteroinferior.
- Identificación de martillo y mango, pars tensa y pars flácida.

Hallazgos patológicos frecuentes:

Hallazgo	Diagnóstico probable
Eritema y edema del conducto	Otitis externa
Membrana abombada, eritematosa	Otitis media aguda
Perforación central	Otitis media crónica
Nivel hidroaéreo	Otitis serosa
Opacificación o retracción	Disfunción tubárica
Cuerpo extraño	Frecuente en niños

Pruebas complementarias simples:

- **Prueba de Rinne y Weber (diapasón 512 Hz):**
 - **Rinne positivo (normal):** conducción aérea > ósea.
 - **Weber lateralizado:** indica tipo de hipoacusia (conductiva o neurosensorial).

3.2 Exploración nasal (rinoscopía anterior)

A) Inspección externa

Observar forma del dorso nasal, desviaciones, lesiones, secreción o costras.

B) Rinoscopía anterior

Instrumento: espéculo nasal, buena iluminación y depresor si es necesario.

Técnica:

- Paciente con cabeza ligeramente hacia atrás.
- Separar narinas suavemente sin causar dolor.
- Explorar tabique, cornetes y meatos.

Hallazgos normales:

- Mucosa rosada, brillante y húmeda.
- Cornetes bien definidos.
- Tabique centrado.
- Secreción escasa y clara.

Hallazgos patológicos:

Hallazgo	Diagnóstico probable
Mucosa pálida, edematosa	Rinitis alérgica
Mucosa hiperémica y secreción purulenta	Rinitis infecciosa o sinusitis
Rinorrea unilateral purulenta en niño	Cuerpo extraño
Tabique desviado o perforado	Trauma, cirugía o consumo de cocaína
Masa polipoidea translúcida	Poliposis nasal
Sangrado anterior (plexo de Kiesselbach)	Epistaxis anterior

3.3 Exploración de la orofaringe

A) Inspección general

Instrumento: bajalenguas y buena iluminación.

Observar: labios, mucosa oral, dientes, lengua, paladar, úvula y pilares amigdalinos.

Hallazgos normales:

- Mucosa húmeda y rosada.
- Amígdalas pequeñas o medianas, simétricas.
- Uvula centrada.

Hallazgos patológicos:

Hallazgo	Diagnóstico probable
Exudado amigdalar y fiebre	Faringoamigdalitis bacteriana
Aumento unilateral con desviación uvular	Absceso periamigdalino
Ulceraciones blanquecinas dolorosas	Aftas
Placas blanquecinas que se desprenden	Candidiasis oral
Masa dura o ulcerada no dolorosa	Sospecha de cáncer oral
Halitosis y secreción purulenta	Amigdalitis crónica

B) Evaluación funcional

- Pedir al paciente que diga “ah” → evalúa elevación simétrica del paladar.
 - Desviación de úvula: lesión del nervio glossofaríngeo (IX) o vago (X).
- Explorar reflejo nauseoso: útil para evaluar pares craneales IX y X.

3.4 Exploración de la laringe (laringoscopia indirecta)

A) Técnica

Instrumento: espejo laríngeo calentado para evitar empañamiento.

Procedimiento:

- Paciente sentado, lengua protruyendo.
- Médico sostiene la lengua con gasa y coloca el espejo en la orofaringe posterior.
- Iluminación frontal (reflex espéculo o fuente de luz).

B) Estructuras visibles:

- Epiglotis.
- Cuerdas vocales verdaderas y falsas.
- Aritenoides.
- Comisura posterior.

C) Hallazgos normales:

- Cuerdas vocales blancas, móviles y simétricas.
- Abertura completa al inspirar; cierre en fonación.

D) Hallazgos patológicos:

Hallazgo	Diagnóstico probable
Hiperemia y edema difuso	Laringitis aguda
Pólipo o nódulo	Disfonía crónica, abuso vocal

Inmovilidad unilateral	Parálisis de cuerda vocal
Lesión infiltrante o irregular	Sospecha de cáncer laríngeo
Edema supraglótico severo	Epiglotitis o angioedema (urgencia)

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Región	Examen complementario	Utilidad
Oído	Audiometría, timpanometría, TAC temporal	Cuantificar hipoacusia, detectar otitis media o colesteatoma
Nariz y senos	Endoscopía nasal, TAC senos paranasales	Rinitis crónica, poliposis, sinusitis
Faringe	Cultivo faríngeo, test rápido de estreptococo	Confirmar faringitis bacteriana
Laringe	Fibrolaringoscopía flexible	Visualizar lesiones subglóticas o neoplasias
Cuello	Ecografía, TAC	Evaluar masas, adenopatías o abscesos profundos

Criterios de derivación a ORL:

- Disfonía >3 semanas.
- Otagia sin causa evidente.
- Epistaxis recurrente o posterior.

- Obstrucción nasal persistente unilateral.
 - Masa cervical o ulceración oral persistente >2 semanas.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El examen ORL no tiene tratamiento en sí, pero su correcta ejecución orienta el manejo inicial:

- **Otoscopía:** permite indicar o descartar antibióticos en otitis media.
- **Rinoscopía:** define necesidad de antihistamínicos o corticoides tópicos.
- **Orofaringe:** diferencia entre infección viral y bacteriana (criterios de Centor).
- **Laringoscopia:** permite sospechar lesiones obstructivas y derivar oportunamente.

En Atención Primaria, las guías MINSAL enfatizan:

- Uso racional de antibióticos.
 - Derivación precoz de patologías neoplásicas.
 - Evitar manipulación excesiva del CAE o nasofaringe.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Procedimiento	Posible complicación	Prevención
Otoscopía	Dolor o lesión timpánica	Evitar presión excesiva
Rinoscopía	Epistaxis	No manipular cornetes edematizados

Exploración faríngea	Náusea o vómito	Usar bajalenguas suave y tranquilizar al paciente
Laringoscopia indirecta	Reflejo tusígeno, laringoespasma	Evitar contacto con epiglotis; anestesia tópica en casos necesarios

El **pronóstico diagnóstico** mejora notablemente cuando el examen físico ORL es completo y sistemático, reduciendo errores y permitiendo intervenciones precoces.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Siempre examinar ambos oídos**, incluso si el paciente refiere síntomas unilaterales.
2. En **niños**, el dolor al traccionar el pabellón sugiere **otitis externa**, no media.
3. **Rinorrea unilateral fétida** en niño → sospechar **cuerpo extraño nasal**.
4. **Úvula desviada y trismus** → pensar en **absceso periamigdalino**.
5. **Disfonía persistente** debe derivarse a ORL para descartar **lesión tumoral**.
6. En **epistaxis**, identificar si es **anterior (Kiesselbach)** o **posterior** (más grave).
7. **Examen del cuello** es parte obligatoria del examen ORL.

Errores comunes

- No retirar el cerumen antes de evaluar el tímpano.
- Usar espéculo nasal excesivamente grande o causar sangrado.
- Diagnosticar “amigdalitis bacteriana” sin criterios clínicos.
- No visualizar las cuerdas vocales en pacientes con disfonía prolongada.

- Omitir la palpación cervical ante masas o adenopatías.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **examen físico ORL básico** incluye otoscopía, rinoscopía, exploración de orofaringe y laringoscopía indirecta.
2. Permite **identificar las causas más frecuentes** de otalgia, rinorrea, disfonía y disfagia en atención primaria.
3. La **otoscopía correcta** es esencial para diferenciar otitis externa, media y perforación timpánica.
4. En **rinoscopía**, evaluar mucosa, tabique y cornetes orienta a rinitis o sinusitis.
5. La **orofaringe** debe evaluarse en toda odinofagia o fiebre; buscar asimetría o exudado.
6. La **laringoscopía** detecta lesiones funcionales o tumorales que se manifiestan por disfonía.
7. Un **examen ORL completo y sistemático** mejora el diagnóstico, evita errores terapéuticos y salva vidas ante urgencias laríngeas.